

**Консультація по наданому МРТ головного мозку з в\в контрастуванням від
20.01.2023 (з урахуванням даних від 13.01.2023р.), МР-ангіографія головного мозку**

ПІБ пацієнта: Жерліцина Анастасія Станіславівна

Дата народження: 25.04.1976

Дата дослідження: 20.01.2023

Дата консультації: 23.01.2023

№ PMDA1525

МРТ в динаміці від 13.01.2023р.

З анамнеза – лейоміосаркома матки T2NxM1. Стан після 4-х циклів ХТ по протоколу Гемцитабін+Доцетаксел+Авастин з прогресією в печінці. Виявлено мутації Kit, з приводу чого рекомендовано прийом Пазопанібу (згідно консультаційного висновка онколога від 4.01.2023р).

Від МРТ за 13.01.2023р. проведене лікування, на фоні якого, зі слів родича, неврологічний стан пацієнтки покращився, проте, на момент консультації відповідної медичної документації не представлено.

На серії МР-томограм головного мозку зберігаються раніше описані дифузні осередки гіперінтенсивного МР-сигналу на T2WI та T2blade dark-fl в кортикально-субкортикальних відділах обох півкуль головного мозку, проте, з помірним їх регресом у вигляді деякого зменшення розмірів, менш гіперінтенсивного МР-сигналу на T2blade dark-fl та із значним зменшенням ділянок накопичення контрастного препарату.

Натомість, в раніше описаній патологічній ділянці в лівій потиличній області визначається поява вогнища внутрішньомозкової геморагії загальними умовними розмірами 14x11x18мм, з ознаками обмеження дифузії та з перифокальним набряком мозкової речовини, шириною до 10,2мм; дрібний геморагічний осередок в правій потиличній області на фоні зони гіперінтенсивного МР-сигналу на T2blade dark-fl наразі без динаміки.

Спостерігається поява нових вогнищ гіперінтенсивного МР-сигналу на T2blade dark-fl в корі медіальних відділів обох тім'яних часток мозку, вогнища демонструють гіперінтенсивний МР-сигнал на DWI (b=1000), одне з вогнищ в правій тім'яній частці з обмеженням коефіцієнта дифузії по ADC, розміри вогнищ праворуч (2 вогнища) 18,7x13,8мм та 12x12,5мм, ліворуч – 7,2x9,5мм. Вказані вогнища контрастний препарат не накопичують.

За ходом субарахноїдальних просторів в лобних областях зберігаються ділянки гіпоінтенсивного МР-сигналу на SWI, підвищеного на T2WI та T2blade dark-fl, які не визначаються на DWI та не накопичують контрастний препарат (можливо, наслідки локального САК чи геморагічного просякнення).

Серединні структури без латерального зміщення. Бічні шлуночки мозку симетричні, в розмірах не змінені, IV шлуночок розміщений по середній лінії. Розмежування сірої та білої речовини чітке.

Перивентрикулярні зони лейкоареозу шириною до 2мм.

VERTE!!!

Мозолисте тіло, базальні ганглії, мезенцефальні структури, структури задньої черепної ями, стовбур мозку ділянок патологічної зміни МР-сигналу не містять.

Краніовертебральний перехід: мигдалики мозочка без ознак пролабування у великий потиличний отвір.

Турецьке сидло: розташоване типово, звичайної конфігурації. Стінки рівні, контури гладкі, чіткі. Лійка гіпофіза розташована чітко по центру. Гіпофіз бобоподібної форми, верхній край симетричний.

Хіазма, зорові нерви без особливостей.

Пневматизація приносних пазух не порушена.

При МР-ангіографії визначається асиметрія діаметрів ділянок А1 ПМАА із зменшенням діаметра праворуч, що може відповідати гіпоплазії. Передня сполучна артерія нормально розвинена.

В ділянках М1 обох СМАА візуалізуються ділянки нерівномірного звуження судин, які можуть відповідати вазоспазму чи вазоконстрикції. МР-сигнал від дистальних гілок СМАА простежується. Визначається зменшення діаметрів дистальних гілок задніх мозкових артерій, а також ділянки А2 правої ПМА, можливо, внаслідок вазоспазму чи вазоконстрикції.

Внутрішні сонні артерії мають нормальний хід та діаметр, розташовані симетрично, виражені чітко. Визначається мішководна аневризма супракліноїдного сегмента лівої ВСА діаметром 2,6мм.

Основна артерія має звичайний хід і діаметр.

Висновок: МР-картина патологічних змін в головному мозку, враховуючи дані клініки та анамнеза, локалізацію та МР-характеристики, чергування зон регресу деяких вогнищ та появу нових вогнищ при динамічному спостереженні за короткий проміжок часу (попереднє МРТ головного мозку від 13.01.2023р.), може відповідати posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES); слід диференціювати з проявами церебрального васкуліту. В порівнянні з попереднім МРТ обстеженням від 13.01.2023р. визначається поява вогнища внутрішньомозкового крововиливу в лівій потиличній частці мозку, вогнищ гостро-підгострої ішемії чи ділянок набряку кори в обох тім'яних частках мозку на фоні вазоспазму та вазоконстрикції церебральних артерій. МР-ознаки мішководної аневризми (МА) супракліноїдного сегмента лівої ВСА.

Доцільні: клініко-томографічне співставлення, МР-контроль в динаміці, спостереження невролога, консультація судинного нейрохірурга.

Лікар



к. мед. н. Скорохода Анна Орестівна

Шановний пацієнт! Дані дослідження не є клінічним діагнозом.

Вам необхідно передати їх Вашому лікуючому лікарю, який дасть роз'яснення по результатам обстеження і встановить заключний діагноз.

Для спостереження в динаміці попередьте наш персонал та надайте диск з попереднім дослідженням, яке проведене в нашому закладі.

23.01.2023 17:06:18 Протокол підготовлено: Дмитришин Віта Іванівна

№ 01-20/128 B04 05.08.2020